

تفريغ مجالس

ألف باء التربية - 42

مع د. عبد الرحمن ذاكر الهاشمي



المجلس الثاني والأربعون

ملخص المجلس

رابط المجلس

أيقونات تفاعلية

تفريغ صوتي

فقه
النفوس
مكاني

تفريغ مجالس ألف باء التربية 42
المشكلات التربوية 02

فهرس

3.....مقدمة

3.....مراجعة لما سبق

5.....اضطرابات النوم

10.....الأرق

11.....التبول الليلي

20.....اللهاية ومص الإصبع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، ربّ اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدة من لساني، يفقهوا قولي، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تُعلمنا، واجعله حُجَّةً لنا بين يديك، اللهم آمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مراجعة لما سبق

مُراجعة لما بدأنا به المرة الماضية:

نحن بدأنا الآن بعدما وضعنا ما نراه البناء الصحيّ، السوي في موضوع التربية، من الطبيعي أن الحياة فيها مشكلات، وبالتالي بدأنا نتكلم الآن عن المشكلات التربوية، وقلنا أول شيء ينبغي أن يُعاد تعريف المشكلة، لأن كثيراً من الناس ما يظنونه مشكلةً قد لا يكون مشكلةً حقيقية، هذا يعتمد على تذكر هذه الدنيا، سنن هذه الدنيا، طبيعة هذه الدنيا، رفع المعقولات كما نسميه في فقه النفس، خفض التوقعات، هذا كله يُعدّ الأب والأم إلى أن يستشعروا حقيقة ما الذي يستحق؟ وما الذي لا يستحق؟ ثم بدأنا بعد ذلك بسرد المشكلات بترتيب زمني بحسب ظهورها في حياة الأطفال.

- بدأنا بقضية: كيفية التعامل مع قضية البكاء والصراخ؟

لأن هذه هي لغة الطفل، وقلنا أن الأمر يحتاج أن نعتاد على لغة الطفل؛ لأن البكاء هو لغته الطبيعية، يبقى علينا أن نعرف ما الذي ينحرف عن هذه اللغة الطبيعية، وبالتالي يحتاج منا الالتفات إليه، فهذا أولاً يحتاج إلى معرفة الأصوات الطبيعية عند الأطفال، وما الذي يدل عليه كل صوت، هذا البكاء بكاء جوع، هذا البكاء بكاء خوف، هذا البكاء بكاء.. وهكذا.

الأمر الآخر، تعويد النفس على هذا الصوت، وعدم السماح لهذا الصوت أن يؤثر أو يُسبب انفعالاً عند الطرفين، وهذا جزء منه -للأسف كما قلنا المرة الماضية- يلعب فيه دور كبير الانشغال الزائد بالآخرين من حولنا: ما الذي سيقولونه؟ أنتم لا تعرفون كيف تُربوا أولادكم، أزعجتمونا.. إلى آخره.

هنا يوجد مسألة كان من يجب أن أعلق عليها وغفلت، التي هي: كيف نتوسط بين ألا أنشغل كثيراً بالآخرين، وبين أنه يجب أن أربي ابني؟

هذه المعادلة قد تكون صعبة، بالذات عندما يكون الوضع الذي حولي وضع لي فيه قدرًا من الحرية، يعني أنا عندما أكون في مكان مغلق، أنا مثلاً في حافلة زُكَّاب، أو في طائرة، أو في قطار، أو في مصعد، أو في.. هناك بعض الأماكن لا أستطيع التصرف فيها، لكن يوجد بعض الأماكن أستطيع التصرف فيها، هناك

بالتأكيد فرق بين الأمرين، عندما يكون لدي حرية في التصرف، فيجب أن أتصرف بمصلحة ومفسدة، هل الآن من أجل أن أربي ابني أزعج الآخرين، ولا أدعهم ينتهبوا، أو لا أدعهم يسمعون.

هل هذا مثل أنني لا أستطيع الآن أن أفعل معه شيئاً؟ وبالتالي أضطر كما قلت لكم مرة قضية أن الواحد يكتفم نفس ابنه أو كذا؟ لا طبعاً، أنا عندي ابني أحاول في وسط الناس أن أشتت انتباهه، أُلعبه لعبة معينة، أُلبيه إلهاءةً مُعيناً، لأنني أخفف الوضع الآن، إذا شعرت أن من حولي ليس لديهم إشكال، وصدقاً ليس لديهم إشكال، ويستحملون صوت الابن، فأدعه يعمل ما يريد، بل أحياناً-كما قلت لو تذكرون- لا يوجد لديّ إشكال أن أدع غيري هو الذي يوجّه، يعني دعه يرى الناس وهم ينظرون إليه؛ لأنه مُعتاد على شكل الوالد والوالدة، وبالتالي ليس لديه إشكال أن يتجاوز الحد هنا، لكن عندما يكون مع شخص آخر سيتعلم الانضباط نوعاً ما.

لكن عندما يكون لدي مساحة من الحرية، فلا، قد يكون أفضل شيء أن آخذ الطفل بعيداً، لأن الناس من حقهم أن يسمعون، أن يُركزوا، أو.. يعني مثلاً من المواقف التي حصلت، بالأمس في المستشفى طفل بكاءه بكاء الابتزاز العاطفي هذا، أظنه حول الثالثة، نحن في مستشفى، اسمه مستشفى، أناس مرضى، نعم من الممكن أن يحتمل المريض رغماً عنه أن يسمع صوت أنين مريض آخر، لكنه ليس مضطراً أن يسمع بكاء الطفل، وتجده هذه الأم تحاول أن تُسكته وهي في مكانها، يا أختي قومي! أنا أنظر إليها: قومي! أمسكيه، وأخرج به للخارج أمشي به قليلاً.

هنا المصلحة أن لا تُربي ابنك الآن في المستشفى، هذا من الممكن أن أرضاه في حضانه، روضة، مدرسة، في مكان يقبل فيه الآخرون هذا الأمر، ما عدا ذلك المسألة تحتاج أحياناً نوعاً من القياس.

وقلنا أن الإشكال الكبير عند الأهالي أنهم لا يحتملون هذا الأمر؛ لأنهم يتصورون أن هذا يؤلم الطفل، وبالتالي سيُعقده وكذا، وقلنا أن هذا الكلام رجعنا به إلى مغالطات بدأنا بها في بدايات المجالس، وأن الطفل ليس لديه إشكال مع الألم بشرط أن يكون هذا الألم في بيئة مطمئنة، ولا يكون انتقاماً، ولا يكون لا تفسير له لاحقاً عند الطفل.

وأيضاً أشرنا إلى ضرورة تدريب الطفل على أن يأنس بنفسه، على أن يعتاد أنه عندما يتمكن من الطلب، يتمكن منه بالطريقة الأمثل طالما أنه قادر عليها. هذا باختصار.

اليوم سأحاول -إن شاء الله- في الوقت المتاح أن نتحدث عن أمرين:

- أولاً: اضطرابات النوم، والأرق، والتبول الليلي.
- ثانياً: سننتقل -إذا أمكن لنا ذلك- إلى الكلام عن الخوف والخجل؛ لأنهما متقاطعان زمنياً، وعادةً ما يظهران معاً، يعني عادةً الأرق والتبول اللاإرادي أو التبول الليلي يتعلق أيضاً بشيء من الخوف.

على أي حال، نبدأ باضطرابات النوم.

❖ الرُّضْع - بداية الحياة:-

أولاً مما يُشكل على كثير من الأهالي أيضاً اضطرابات النوم في بداية الحياة عند الطفل، يعني في الأيام الأولى، والأسابيع الأولى، هذا الكلام تناولناه في البدايات في الخطة اليومية، وعلاقة ما قلنا في الخطة اليومية بهذا الكلام أنه ما يجري من الطفل الرضيع في أسابيعه الأولى هو في غالب الأحوال امتداد لما عودته عليه الأم الحامل.

مرة أخرى، ما يجري من الطفل في الأسابيع الأولى هو امتداد لما عودته عليه الأم الحامل، عندما أقول غالباً فيعني هذا أنه يوجد استثناءات، يعني قد تكون الأم عملت الذي علمها، وجدولها الزمني جيد، وكان رايقة، ولا يوجد صخب، لا يوجد مشاكل، ولا يوجد تدخين، لا يوجد كافيين زائد، ولا يوجد كذا، ومع ذلك يظهر، هذا استثناء، أنا أتكلم أن الأصل أن الأم الحامل إذا كانت خطتها، وإذا كان جدولها اليومي، وهدهدها، وتعاملها مع قضية عدم السهر وكذا ثابت خلال الحمل، فغالباً الطفل واسألوا كثيرات ممن تعرفن، سيقبلن لكن: نعم، أنا الحمد لله طفلي لم يُتعبني، يعني يستيقظ، يرضع ثم ينام، وهكذا، أحياناً يحدث له مغص، هذا طبيعي، لكن أنه من البداية، منذ أول يومين الطفل لا ينام إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، ويُسهرها، وبعد الفجر فجأة هكذا يُعطى راحةً وينام إلى الساعة الثانية ظهراً، هذه هنا أنا أتساءل: كيف تعود الطفل على هذا؟ لأن النوم عادة، وقت النوم عادة، أنت عودتيه على هذا الأمر.

فإذاً أول شيء يُرجع به هنا هو ما قلناه في الخطة، أن الأم الحامل يجب أن يكون لديها خطة، وبالتالي تُعود الطفل عليها، وإذا تذكرن من الأشياء التي أشرنا لها من الأخطاء الشائعة عند الأمهات قضية التجول في المولات، وتعويد الطفل الذي في الرحم على حالة الصخب، وسهر، عزومات، وكذا، هي حامل لكنها تنام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، يوجد شيء الآن يُسمى الساعة البيولوجية، أنت تُعوّدين الساعة البيولوجية التي لدى الجنين -الذي سيصبح رضيعاً بعد قليل- تعوّدينه على هذا، وبالتالي سيصعب عليه فجأة أن تطلبي منه أن ينام الساعة الثامنة، أو الساعة التاسعة، صعب، حتى مع احتياجه لذلك، وهنا لا عجب عندما ترون رضيعاً يبكي بحرقة يريد أن ينام ولا يستطيع النوم؛ لأنه يوجد حاجة جسدية، هو يحتاج النوم، الرضيع يحتاج ما لا يقل عن أربعة عشر إلى خمسة عشر ساعة نوم، تصوّروا، أما بقية الساعات فيرضع، ويلعب قليلاً، فقط، ثم ينام، هو يحتاج إلى ذلك، طبعاً لا أريد الخوض في ذلك، قضية حاجة الأكسجين، والدماغ، وتكوّن الدماغ في أول سنة، سنتين، لكن هو يحتاج ذلك، ومع حاجته لذلك هو لا يستطيع التعبير عن هذا الألم إلا بالبكاء، ولأنه لم يعتد على النوم بهذه الطريقة فتلقائياً أنت تتحملينها، أنه يبكي بكاءً بحرقة حقيقية، هو فعلاً يريد أن ينام ولا يستطيع النوم.

إذاً كبداءية، كثير مما قلناه في الخطة التربوية لأبْد أن يُستدعى هنا، لأن عادة النوم يجب أن تكون مُلحقة بما اعتاده هذا الجنين من أمه في أيام الحمل.

• الاستثناءات:

أولاً: أن يكون هنالك مشكلة عضوية بحتة.

بمعنى أن يكون مولوداً ولديه إشكال مُعين، التهاب مُعين، تحسس معين، وهذا موجود، وهذا سهل عند أي طبيب أطفال، أو حتى أي طبيب عام يفهم بعض الشيء، الواحد في هذه الأيام لأجل موضوع المستشفيات ينزعج أنه أنت صُرفت عليك نقود، وست سنوات طبّ، وكذا، وإلى الآن لا تستطيع أن تُشخص مسألةً بديهية؟ لا تستطيع أن تطلب فحصاً الأصل أن يُطلب؟ هذا موجود للأسف مع أن الواحد الحمد لله يعني نحن في بلد من المفترض أن الخدمة الطبية، أو على الأقل الكادر الطبي فيها أفضل من كثير ممن نعرف من حولنا من البلدان، لكن أولاً قد يكون سبباً عضوياً بحثاً، وهذا بعدما قلنا كيفية التعرف على صوت البكاء غير الاعتيادي، من السهل أن تستوعب الأم أن هنا يوجد بكاء غير اعتيادي، وبالتالي أول شيء يجب أن أفعله أن أتأكد أن الطفل لا يوجد لديه إشكال عضوي، وذلك بزيارة طبيب أو طبيبة أطفال.

ثانياً: قد يكون الأمر ليس مسألةً جسدية، وإنما اضطراب حاصل في البيت.

بمعنى الصخب، التوتر الذي في البيت قد يُسبب عند الرضيع -حتى عند الرضيع في بداياته- شيء من الاضطراب في النوم، لا يوجد لدينا نظرية مكتملة تُفسر هذا الأمر، يوجد فرضيات، نظريات، ما بين وبين، من يقولون بأن الأمر ظاهر، أنه عندما يكون هنالك إشكال بين الوالدين، يوجد توتر، يوجد حتى أحياناً تعنيف بين الوالدين، يظهر هذا باضطرابات نوم عند الرضيع، أقول عند الرضيع أي قد يكون بعمر الشهر، شهران، ومع ذلك يضطرب النوم لديه، وليس لديه أي سبب عضوي، والأم تنام باكراً وليس لديها مشكلة، التفسيرات قد يكون هنالك حالة توتر في البيت فتنعكس.

ما هو التفسير لذلك؟

لا يوجد، لا يوجد لدينا شيء نستطيع الاحتكام إليه، لأنكم تعرفون -تذكرون عندما كنا نقول أن التعامل مع الرضيع نُسميه التعامل مع الأخرس- أمامك كائن تتكهن ما الذي يجري معه، ولذلك تبدأ الفرضيات، هل يا ترى حصل كذا، هل يا ترى حصل كذا، هل يا ترى حصل كذا؟

وإذا كنتم تعرفون أناساً من الذين يتعاملون مع الأطفال -أقصد طبّ الأطفال- يقولون لكم:

نعم، طبّ الأطفال بقدر ما فيه مُتعة، لكنه صعب جداً، أنت أمام كائن تستنطقه استنطاقاً، والباقي كله تُكمّله من فراغ، تُكمّله من خيالك، هل يا ترى حصل كذا؟ هل يا ترى حصل كذا؟ هل يا ترى حصل كذا؟

ألف باء الترية

لكن هذه أيضًا من الأشياء التي تُقال، أنه قد يكون من الأسباب شيء حصل في البيت، وإذا كان الأمر كذلك فهذا الأمر لا يحتاج طبييًا، هذا الأمر يحتاج إلى شيء من التبصر. هل نحن فعلاً لدينا مشكلة؟

ثالثًا: واحدة من الأشياء التابعة وهي أكثر وضوحًا من غيرها، هي اكتئاب ما بعد الحمل (أو الوضع).

هذه ظاهرة أكثر بأن المرأة التي تنجب وقد شُخصت بالاكتئاب من علامات ذلك ظهور اضطرابات النوم لدى الرضيع؛ لاحظوا أنني أقول هنا إن هذه العلامة أظهر من غيرها، لأن الكلام الذي سبق كان نوعًا ما عامًا، مثل أن الطفل لا يستطيع النوم بسبب وجود مشكلة في البيت؛ قد يقول أحدهم فما علاقة ذلك؟ ما علاقة الطفل بالأهل المتشاجرين؟ ما مشكلته هو بذلك؟ فأقول بالطبع هذا حاصل.

لكن في حالة اكتئاب ما بعد الحمل أو الوضع يظهر الأمر؛ هناك نسبة لا بأس بها من النساء قد يكن كارهات لفكرة الأمومة، أو غير مستعدة لها، ربما كانت المرأة تكره الأب، أو كانت تنوي الطلاق قبل الحمل لكنها حملت فتورطت، وأيًا كان السبب؛ هنالك نسبة لا بأس بها من هذا النوع من الأمهات يظهر لدي أطفالهم الرضيع اضطرابات النوم.

عندما نقول اضطرابات النوم، نعيد التوضيح: هي ليست فقط عدم القدرة على النوم، بل تترافق عادة مع بكاء شديد، وأحيانًا صراخ. فالطفل عادة لا يستطيع النوم، فيظل مستيقظًا، ثم ينام بعد تعب، لكن تكون المشكلة بأنه لا يستطيع النوم ويبكي بكاء شديد.

هذا الأمر في حالة الرضيع قد يكون إما شللاً عضويًا أو شللاً نفسيًا؛ بالنسبة للشيء النفسي، هناك ما ليس لدينا عليه مستند علمي واضح بشأنها، وأخرى توجد نسبة واضحة لارتباطها بما يسمى اكتئاب الأم أو اكتئاب ما بعد الحمل أو الوضع.

رابعًا: تبقى مسألة واحدة فقط في حالة الرضيع، وهي أن تكون الأم أثناء فترة الحمل كانت لديها إشكالات تتعلق بالإفراط في تناول المنبهات، أو لا قدر الله المخدرات، هذا الأمر له تأثير ظاهر، فالأم التي تنجب وهي في تلك الحالة قد تظهر نسبة كبيرة من أطفالها اضطرابات في النوم، وربما يُعترض أن الكافيين ليست بمستوى المخدرات، ولكنه الظاهر أن الأم المدخنة بشراهة أثناء الحمل قد يظهر أطفالها اضطرابات نوم بنسبة لا بأس بها.

لهذا يعجبني عندما يُقال كلام من الشعبويين (الناس الذين يتكلمون كلام غير علمي) كلام يخيف الأمهات مثل (ابنك يدخن معك أو يتعاطى معك) رغم أنه ليس علميًا 100% إلا أن فيه قدرًا من الصحة فيما نلاحظه في حالات اضطرابات النوم لدى الأطفال في مرحلة الرضاعة.

❖ السنة ونصف وسنتان:

إذا انتقلنا إلى مرحلة عمرية أكبر، كالسنة والنصف أو سنتين، فإن اضطراب النوم عادة ما يكون نتيجة اعتياد من البيئة، المشكلة تبدأ منذ أن الحامل عودت الطفل على نمط معين، نفس الشيء، الطفل

ألف باء الترية

عندما يكون قد مضى على ولادته سنة أو 365 يومًا، يكون قد اعتاد على نمط حياة معين، حتى لو كانت هناك في البداية مشاكل. كثير من الحالات التي نراها، نعم، في البداية قد تكون هناك مشاكل، مهما كان السبب عضوياً أو نفسياً، لكن بعد قليل نري أن الأمور قد تترتت إذا استطاع الأهل ترتيبها، لكن عندما يكون هناك سهر أو استخدام للهواتف الرقمية المفتوحة معظم الوقت، أو الآيباد، أو شاشة التلفاز في البيت، أو العزائم والولائم، والتنقل المستمر، فإن هذا الأمر سيؤثر تلقائياً علي الطفل وسي تعود على هذا النمط، وبالتالي يصبح من الطبيعي جداً أنه عندما يكون في عمر السنة والنصف أو السنتين لا يستطيع النوم مبكراً، حتى لو نام والده ووالدته. لأنه قد تعود على هذا النمط.

هل تتذكرون عندما قلنا توبة الأم؟ في اللاحقة هذه، كانت الأم هكذا، لكنها الآن تستطيع أن تضع نفسها رغماً عنها في السرير لأنها ناضجة، والمفروض أنها عاقلة وتعرف، أما الطفل فهو لا يملك هذا سيقول: ما الذي استجد؟ لماذا فجأة غيرتم النظام وتريدوني أن أنام مبكراً؟ أنتم عودتموني على النوم متأخراً.

هذا هو السبب الأول، وهو للأسف نمط الحياة.

السبب الثاني هو شيء أوردناه، وأتذكره في الخطة اليومية، وقد أطلنا النفس فيه، وهو الأنس الموجود عند الطفل، فالطفل كائن يأنس، ويحب دائماً أن يشعر بالأمن والأنس مع ما أو من حوله. فجأة يُقال له: اذهب ونم وحدك، وقد ذكرنا هذا وتحدثنا عنه في الخطة، وتحدثنا حتى عن كيفية التعامل معه.

أنا سأشرح كيفية التعامل مع تجاوز الحد عندما يتحول إلى معضلة أو يصعب على الأهل أن يعرفوا كيف ينام الطفل، وسأتحدث عن هذا بعد قليل، لكن السبب هنا هو أن الطفل لم يُعوّد على النوم بمفرده، يعني أن الأهل لم يلتزموا بالتدريب كما ينبغي فيما ذكرناه في الخطة.

القضية الثالثة هي الخوف: ما هو الخوف؟ هو خوف حقيقي، من أين يأتي هذا الخوف؟ هناك عدة أسباب لذلك، قد يكون من ارتباط الحديث عن النوم والظلام مع الأهل بالخوف، أو مثلاً: (إذا ما عملت كذا، سأضعلك في الغرفة المعتمدة)، أو أطفئ الضوء عليه، أو أخوفه أو تخوفه بعبارات وعظية لا تستند إلى طرح شرعي صحيح، مثل أن نقول: (أنه عندما تغرب الشمس تنتشر الجن، فاحذروا وخافوا على أولادكم وأمسكوا أولادكم)، خافوا على أولادكم ولكن ما علاقة هذا بكون الطفل في البيت أو في سريريه؟

وهناك أسباب أخرى مثل مشاهدة مقاطع مخيفة، والغريب أنه لا يوجد لدينا مستند علمي على ذلك! بل توجد دراسات تثبت العكس: بعض الأطفال يشاهدون أفلاماً مرعبة ثم ينامون بسهولة لماذا؟ الأمر يعود إلى اعتيادهم فقد يرون هذه المشاهد كأنها أحداث مثيرة، مثل قراءة قصة خيالية ك (هاري بوتر)، حيث يوجد طيران وجن وسحر وغير ذلك، ثم ينامون دون أي مشكلة. لذلك، القول بأن: ابنكم لا ينام لأنه شاهد شيئاً مخيفاً اليوم، ليس دائماً صحيح، لكن الأكثر وضوحاً هو أن اضطراب النوم قد يكون نتيجة

ألف باء التربية

حالة توتر في البيت هذا الأمر نعم لدينا عليه مستندات علمية، وهنا يختلف عن حالة الرضيع؛ الطفل الأكبر سنًا من عمر سنة ونصف إلى ثلاث سنوات أو أكثر، يستطيع الربط بين الأسباب والنتائج شعورنا بأن هناك توترًا في المنزل يمكن أن يظهر أثره على الطفل بشكل أوضح. اضطرابات النوم عند الأطفال الأكبر سنًا، خاصة بين ثلاث وخمس سنوات، قد تكون مرتبطة بخلافات أو توترات بين الوالدين، الأب والأم هما مصدر الأمان الأساسي للطفل، وعندما يشعر الطفل بأن بيئته غير مستقرة، يظهر ذلك في سلوكياته بما فيها النوم.

سأذكر قصة شخصية عن جماعة أعرفهم؛ كانت لديهم طفلة تعاني في طفولتها من بعض الاضطرابات وكان من ضمنها مشكلة النوم، كنت أزورهم أحيانًا قبل موعد نومها لأرى ما يحدث معها، علاقتي بالأطفال كانت طيبة والحمد لله، فكنت ألعب معهم قليلًا، ثم أساعدهم على الذهاب إلى أسرهم، وأغادر، جو البيت كان متوترًا للغاية، والأب والأم كانت علاقتهما سيئة، عندما كنت أزور هذه الطفلة تحديدًا، وهي في سن خمس أو ست سنوات، كنت أجدها في سريرها تبكي. إذا دخلت عليها، كانت تتظاهر بأنها نائمة، معتقدة أن والدها أو والدتها قد دخلوا لكنها حين تدرك أن الداخل هو عبد الرحمن، عندها تبث ما في نفسها كان واضحًا أن الجو المتوتر في البيت ينعكس عليها، فهي طفلة صغيرة تتكلم عن خمس أو ست سنوات هي لا تستطيع معالجة هذا التوتر أو فهمه.

المفارقة أن هذه الطفلة، التي عانت في طفولتها من هذه المشكلات، أصبحت الآن في نهاية العشرينيات، متزوجة وأم ورغم صغر سنها، أصبحت واحدة من أقوى الأمهات وأكثرهن نضجًا وحكمة في التعامل مع أبنائها والتحديات التي واجهتها في صغرها علمتها كيف تكون أمًا قوية وأكثر حماية لأطفالها. الشاهد من هذه القصة أن الاضطراب الذي قد يكون حاصلًا في البيت، خاصة بعد سن السنتين، يمكن أن ينعكس بوضوح على الطفل.

من المسائل المرتبطة أن يكون الطفل قد مرّ بشيء خلال اليوم والطفل عادة لم يتعلم التعبير عن نفسه، سواءً في المدرسة، أو مع أطفال آخرين في الحي، أو حتى في البيت، عندما يعجز الطفل عن التعبير عن مخاوفه أو مشكلاته، يتراكم هذا الشعور ويظهر تلقائيًا عندما يخلو بنفسه في وقت النوم، لأنه الوقت الذي يخلو فيه الطفل بنفسه. سنناقش هذا الأمر ضمن إطار تعليم الطفل كيفية التعبير عن نفسه وكيفية التعبير عن مخاوفه؛ قد يكون هناك أمر حدث في المدرسة، أو مع أولاد العم في الحي أو في البيت ورغم أنه قد لا يتذكره بوضوح، إلا أنه يبقى عالقًا في ذهنه، مما يؤدي إلى مشكلة حقيقية تظهر عند وقت النوم.

إذن، الأسباب الرئيسية قد تكون:

- وجود نمط معين في البت قام الأهل بتعويده عليه.
- توتر في البت ينعكس مباشرة على الطفل.
- شيء حدث داخل أو خارج البت، لكنه لا يستطيع التعبير عنه، فيتراكم لديه إلى أن يظهر وقت النوم.

بالطبع، هناك الأسباب العضوية التي تحدثنا عنها سابقًا عند الرضع، لكنها تأتي لاحقًا في التفكير حينما نستبعد الأسباب النفسية والبيئية. الأسباب العضوية أحيانًا قد تكون هناك أسباب عضوية لاضطراب النوم، مثل وجود التهابات أو مشكلات في الغدد، وإن كانت هذه الأسباب نادرة، لكنها قد تكون موجودة الأسباب تكون إما اعتياد نمط حياة غير صحي أو اضطرابًا في المنزل أو وجود مشكلة داخل البيت أو خارجه لكن الطفل لا يحسن التعبير عنها فتتحول إلى اضطراب في النوم.

❖ سن سبع سنوات:

بعد ذلك تصبح الأمور أكثر وضوحًا، على سبيل المثال عندما نتحدث عن طفل يبلغ سبع سنوات أو ثماني سنوات، يمكن بسهولة تحديد ما إذا كان يعاني من مشكلة حقيقية، أو أنه (يتزانخ)، أو أنه لا يريد النوم لأنه يخشى البقاء بمفرده. هذه تكلمنا عنه في الخطة اليومية سابقًا.

مع اضطراب النوم تلقائيًا يرتبط مصطلحان: مصطلح الأرق ومصطلح التبول الليلي.

الأرق

عندما نذكر الأرق، نجد أن بعض الأهالي يستصعبون هذا المصطلح قد يقولون لماذا يعاني طفلي من الأرق؟ ما الهموم التي لديه؟ هنا التوصيف الطبي لا يرتبط بالضرورة بالأسئلة الوجودية التي لدى ابنك، الأرق يعني ببساطة عدم القدرة على النوم رغم الحاجة الماسة إليه، متى يُوصف الأرق بأنه أرق؟

الأرق هو اضطراب يصف حالة الشخص عندما يحتاج إلى النوم ولكنه لا يستطيع. ولتوصيف الحالة بأنها أرق، يجب أن: تكون مستمرة لفترة طويلة (عدة أيام)، وأن يكون الشخص في حاجة فعلية للنوم.

الأرق لا يُوصف إذا كان الشخص مستلقيًا في السرير ويشاهد التلفاز أو هي تدرش على الواتساب ولا يريد النوم، إنما عندما يكون مستلقيًا ويريد النوم ولا يستطيع فهذا هو الأرق، وإذا كان ليوم واحد فلا يعتبر أرق أما إذا تكررت عدة أيام فهنا نقول عنه أرق.

هل يمكن أن يكون هناك أرق لدى الأطفال؟ نعم، من الممكن أن يحدث الأرق عند الأطفال، قد يكون الرضيع في حاجة شديدة للنوم لكنه لا يستطيع، ومع ذلك لا يُطلق على هذه الحالة (أرق) عند الرضع؛ لأن

ألف باء الترية

الأرق عادةً يرتبط بعوامل نفسية أو أفكار، والرضيع لا يمتلك مثل هذه الأفكار بعد. لذلك، في حالة الرضع، تكون الأسباب غالبًا عضوية مثل الاعتياد على نمط معين، أو وجود التهابات، أو مشاكل صحية أخرى.

ولذلك، من عمر سنتين فما فوق، يمكن أن نطلق على الحالة أرق بشكل صحيح عند الأطفال إذا استمر الأمر عادةً نوصي بمراجعة الطبيب إذا استمر الأرق لمدة تتراوح بين ثلاثة أيام إلى أسبوع دون أن يتم علاجه أو دون القدرة على تحديد السبب، في حال عدم وجود سبب عضوي واضح، ينبغي التوجه مباشرة إلى طبيب أطفال مختص أو طبيب نفسي مختص بالأطفال في بعض الحالات، أو جماعة العلاج الوظيفي أحيانًا.

مرة أخرى، إذا استمر الأمر مع الطفل من ثلاثة أيام إلى أسبوع، ولم نستطع إيجاد السبب، لم نستطع التعامل مع الأمر، لم يعد لحالته، لأنه أحيانًا يوم يومان يكون هنالك سبب، حتى لو لم نعلمه ثم يعود الطفل إلى حالته، لا يوجد إشكال، لكن إذا استمر الأمر أكثر من ذلك، ولا يوجد لدينا سبب عضوي واضح، فنراجع فيه إما أهل العلاج الوظيفي، أو جماعة طب نفس الأطفال، وحينها يكون لكل حالة خصوصيتها وتعاملها مع أهل الاختصاص.

التبول الليلي

نأتي الآن إلى التبول الليلي، التبول الليلي وضعه أكثر خصوصيةً من مجرد اضطراب النوم، ليس كل من لديه اضطراب نوم لديه تبول ليلي، وليس كل من لديه تبول ليلي لديه اضطراب نوم، لأنه من تعريف التبول الليلي أنه يحصل بعد النوم، ويوجد استثناءات لهذا التعريف، يعني يوجد من يحصل لديه تبول ليلي وهو لم يدخل في حالة النوم بعد، وهي نسبة ضئيلة جدًا، وعادةً ما تكون مرتبطة بشيء من اضطرابات النوم، يعني يوجد حالة خوف، فقد يكون مجرد وجوده في السرير، لا يستطيع أن ينام، مخاوف، توتر الله أعلم، قبل أن يدخل في النوم يحصل معه تبول وهو في السرير، مع أنه يعي أنه يتبول الآن، أو هي تعرف أنه يخرج منها سائل، والذي من المفترض أن يكون في الحمام أو في الخلاء، وهذا موجود، ولذلك هذا لا يوصف علميًا بالوصف التام للتبول الليلي، هذا استثناء عن البول الليلي، التبول الليلي معناه أنه دخل في حالة النوم.

نأتي على ما قبل ذلك، لأن التبول الليلي قصة.

مداخلة: يعني التبول الليلي بهذه المرحلة إرادي؟

الدكتور: التبول الليلي شبه إرادي، لذلك سأفصل فيه بعض الشيء، بمعنى ما الذي يحصل مع الطفل حتى يصل إلى هذه المرحلة؟ هذا الكلام سيُعيدنا إلى ما قبل ذلك، والذي في أيام الخطأ أرجأناه إلى هنا، الأصل أن تحكم الطفل بعضلات المثانة بين قوسين يكون قرابة السنة وثمانية أشهر، سنتان، حول

ألف باء التربية

هذا، يوجد من هو في بداياتها فيكون مبكرًا، وَيَعَجَب الأهل أحيانًا أن الطفل يستطيع التحكم، وهناك من يتأخر أحيانًا إلى الثلاثة سنوات، وهذا أيضًا يبقى في الحدود الطبيعية، لكن في عمر الرابعة والخامسة فلدينا إشكال حقيقي، وينبغي أن يُراجع فيه الأطباء، هل يوجد لديه إشكال؟ إشكال في المسالك البولية؟ التهابات؟ كذا.. وغالبًا ما تكون الالتهابات سببًا عند كثير من هؤلاء.

لكن أولًا يجب أن نعرف ما هو الطبيعي، بالمناسبة على قضية الطبيعي، بالأمس نشرت على القناة جدولًا، يوجد دليل اسمه بناء، دليل، فيوجد جدول على قضية ما الخصائص المتعلقة بالأعمار؟

نعود مرةً أخرى، الأصل أن الأبناء إلى عمر السنة وبعدها بقليل، الأصل لديهم أنه يوجد احتياج شديد للغذاء، وبالتالي الكلية بالكاد تتعامل مع السوائل، المثانة على قدرها، وبالتالي الخروج السريع، وهو إلى الآن ليس لديه نُضج كافٍ في معرفة الزمان، والمكان، والاحتياج، وبالتالي الطبيعي لديه أنه من الطبيعي أن يكون لديه إخراج بين قوسين لا إرادي، عندما نقول لا إرادي فهذا يعني أنه يحُس، لكنه يشعر به كشعوره بالجوع، يعني: نعم أنا أشعر أنه يوجد شيء، لكن لا يلزم أن أذهب على الحمام. هذه حالة نُضج يتعلمها فيما بعد، أما في أول سنة ونصف على الأقل، الطبيعي لديه أنه يشعر بمرور شيء من المخرجين كشعوره بالجوع والعطش، لا يلزمه.. يعني كيف لو أنه مثلاً جاع فمدّ يده لشيء لا يحق له أن يمدّ يده عليه؟ هو لازال.. قضية لا يصح، تستأذن أمك وتقول لها أنا جائع، وأريد أن أكل كذا، فتقول لك: أنت أكلت قبل..

هذا كله مسألة متقدمة بالنسبة للرضيع، ولذلك من الطبيعي إلى عمر السنة والنصف أنه.. الأمور سهل لدينا، فوط، حفاظات وغيرها، إشكال الأهل أن البعض يعتمد على هذا لدرجة أنه السبب في تأخير إدراك الابن لقضية الإخراج، والمهمة الأولى هنا هي الأم العاطلة، التي علّموها أن تعمل في الخارج ولا تعمل في الداخل، الواعية جدًا ما الذي يحصل في الشركة؟ من الذي سيُطرد؟ ومن الموظفة.. هي تعي هذه، لكنها لا تعي أن لديها ابنًا أو ابنةً تحتاج أن يُعلّم أو تُعلّم كيف شيئًا فشيئًا يُنبه نفسه؟ وكيف يتنبه إلى حالة الإخراج هذه ويُعلن عنها؟

هذه التدريبات يوجد لها مواد كثيرة منتشرة من الممكن أن يُحال عليها، لكن من أهم التدريبات في نظري هو أن يشعر الطفل بالألم ما بعد الخروج، عندما كنا نتحدث عن الثواب والعقاب، والربط، والسبب والنتيجة، الإشكال في الأطفال أنه عندما يجري منه ذلك فأقصى شيء: "يبيبي" ثم تذهب لتغير له وتعود، لا يوجد أسهل منها، لكن عندما يشعر أنك: "في المرة القادمة عندما تشعر أنك تريد أن تذهب إلى الحمام أخبرني". لا يخبرها لأنه يلعب: لماذا لم يخبرها؟ لأنه يريد أن يلعب.

ولذلك من العادي جدًا وهو يلعب في عمر السنتين، الثلاث، أربعة مع زملائه، وبعد قليل أكتشف أنه فعل شيئًا، أو يصل الأمر-وهذا الشيء مؤسف- عند بعض الأهالي أن تشتم رائحة كريهة، يعني ليس فقط قضية بول، بل يوجد بُراز وهو يلعب؛ لأنه لا يريد أن يُنبّه، أعتاد أن المهم أن يلعب، الألم الذي كنت أعنيه قبل قليل أنه عندما يحصل هذا، بعد مرة، مرتان، ثلاثة من التنبيه، ومحاولة التعويد، وتأكدنا أن

ألف باء التربية

الولد يفهم، ليس لديه إشكال، ليس لديه إعاقة ذهنية، يفهم كلامنا، يفهم ربطنا للسبب والنتيجة، هذا الكلام كله يفهمه، ننتقل إلى إشعاره بالألم، حتى يرتبط هذا المنبه لديه بالألم الذي حصل معه، الألم الذي حصل أنني لن أعاقبه، بل سأقول له: اذهب وغير لوحذك.

طبعًا هو سينزعج، وخصوصًا إذا كان يلعب، لن يستطيع أن يكمل اللعب، خصوصًا إذا سمع له كلمتان جميلتان هكذا، أو نظرات ليست لطيفة من زملائه، فأقول له: اذهب، أنت الذي فعلت هكذا.

حتى.. طبعًا أنوي في داخلي أنني بعد قليل سأذهب وأغير له، لكنني أريده أن يستمر نصف دقيقة، دقيقة، مع هذا الشعور، أما مجرد أن يشعر أن الأمر حصل وعادي جدًا أذهب وأغير له، ومباشرةً غسّلت ونظفت، وكذا، وأعدته مباشرةً أنيقًا، لطيفًا كذا، لن يشعر بشيء.

أكثر من ذلك، أنني أحرمة بعدها من الشيء الذي كان يفعله: يعني ماذا؟ أنت تلعب، فعلت هكذا؟ لا يوجد لعب.

- لكن أولاد عمه موجودون في البيت.

أقول لهم لا بأس، الآن نريد أن نفعل شيئًا آخر، اجلسوا وتحدثوا مع بعض، لكن لا يوجد لعب.

لاحقًا عندما يحصل هذا التنبيه في نفسه تلقائيًا يوجد مُدخل آخر زاحمناه معه وهو الألم، فحينها يريد أن يُنبه الأم لمصلحته الشخصية، حتى لا أتعرض لما عرّضتني إليه من قبل، حتى لا أتعرض لقضية أن ملابسي تتسخ.

على قضية الملابس الوسخة، من أنجح الناس ظاهريًا في القضاء على موضوع التبول اللاإرادي في اليقظة عند الأبناء، ظاهريًا هن الأمهات الموسوسات؛ لأنها يعنيتها جدًا النظافة، سمّيته ظاهريًا لأنها تقضي على ابنها، تقضي تمامًا عليه، رسمة الوجه المرتعب مما حصل، والملابس وكذا، وتُمسكها هكذا بطريقة.. يُشعر الابن أنه قمامة، أنا لا شيء، فهو ظاهريًا يخاف فيما بعد أن يحصل منها هذا تجاهه، وبالتالي أولاً بأول يُنبه، بالعكس هو قبل ساعة من حاجته للأمر يذهب إلى الحمام، لكن هذا يبقى مضطربًا، وقد يستمر معه هذا الأمر -نحن نتكلم عن سنتان، ثلاثة- إلى علامات المدرسة، وخوفه أن يعود مُلطخًا بالطين؛ لأن الأم أشعرته أن الملابس، والسجاد، والكذا أهم عندي من نفسيّتك، ومع ذلك نحن نريد قدرًا من انتباه هذه الأم الموسوسة، قدرًا منه عند الجميع، والذي هو أن تستطيعي أن تقول له: لو فعلت هذا، وبالتالي بعد قليل لا يوجد لديك ملابس، أصبحوا في الغسيل.

أما عندما يكون لديه عشرون بنطالًا، وعشرون غيار، وعشرون كذا، سيشعر أن الحياة مستمرة، شأني شأن الطفل الصغير.

ألف باء التربية

واحدةً من الأشياء اللطيفة التي تُستخدم هنا مع الأطفال هو تخويله من النكوص، الارتداد، هو الآن يريد أن يمارس ممارسات حرة لا يستطيع ممارستها الطفل ذو الشهران والثلاثة، ولو كان لديه أخ فبكل بساطة يُقارن، فنقول له:

طالما هكذا، فسنعاملك كما نُعامل أخيك أو أختك، بمعنى لن نُعطيك الملعقة، لن تضغط على زر الكهرباء، لن تساعدني بتقطيع السلطة.

فيشعر أنه: لحظة، يوجد صلاحيات أفقدها.

ممتاز، هذه الصلاحيات.. خذوا دائماً الحكمة الشديدة من الأقوال الماثورة، والقول الماثور هنا هو قول سبايدر مان: With great power comes great responsibility لا حول ولا قوة إلا بالله، الفيلم الأخير للإيفنجيز يطوف العالم، منظر مؤسف عندما ترون الأطفال بالطواير ينتظرون أبطال الفيلم حتى يوقعوا لهم على قمصانهم، وعلى.. أصبحوا أمثلةً حقيقية الله المستعان، ومع ذلك: With great power comes great responsibility. يعني عادي، يؤخذ الحق من السفية لا يوجد مشكلة.

إذاً، واحدة من الأشياء التي تُعين على تنبيه الطفل بعدما نُعوّده، ونأخذه إلى الخلاء، التي هي تدريبات المعتادة، وكما قلنا في الخطة تكلمنا على قضية الحياء، وليس أن نأخذه ونُعريه ونُجلسه أمامنا، لا طبعاً، مع الحياء، مع.. بعد هذا الكلام كله لم يحصل؟ نبدأ نضطر بإشعاره بشيء من الألم مع التجربة، وبالتالي حرمانه من الشيء، إبقاءه في لباسه على ما هو عليه، مع شيء من ظهور نوع من العتب والزعل، أن: هذا ليس المنظر.. أنت أكبر من ذلك، كبرنا، لم نعد أطفالاً. إلى أن نحرمه من بعض الأشياء المتعلقة بصلاحياته ككبير، وبالتالي يخشى أن يعود كما كان طفلاً رضيعاً لا يستطيع أن يفعل أشياء كثيرة.

هذا كله من المفترض أن يُعين على التخفيف من هذه الحالة، تبقى مسألة أيضاً سأرجئها إلى الإبانة والتعبير وهي أن الطفل قد يكون مر بكل هذا لكنه لا يحسن التعبير، لم يتعلم أن يتوقف ويقول:

أنا أحتاج أن أذهب على الحمام، أمي خذيني على الحمام، أنا أحتاج ان أقضي حاجتي، أحتاج أن أتبول، لا يستطيع أو لا تستطيع.

الأمر المتعلق هنا، أكرر هذا كله سأرجئه إلى الإبانة والتعبير، لكن الأمر المتعلق هنا تعلقاً مباشراً هو أن بعض الأهالي -للأسف- لم يُعلموا أبناءهم الانسحاب بين الحين والحين مما يفعلون، يلعب ويستغرق في اللعب إلى أن يَمَلّ، أما قضية أنه: نتوقف، نريد أن نأكل، نتوقف، نريد أن نغسل أيدينا.

لا، هو لم يتعلم التوقف، هو دائماً يُمضي الأمر إلى أن يَمَلّ، وهذا -للأسف- يكبر معه، ويتحول إلى نمط حياة وهو طالب جامعي، وهي طالبة جامعية، حتى إلى ما بعد ذلك.

هذا الكلام كله كان في حالة اليقظة، هذه الحالة إذا لم تُعالج فتلقائياً ستستمر وستزيد في وجود الطفل لوحده في السرير: وأنا بدون هذه الوساطة عندما أكون بين الناس، ويوجد حركة حولي وكذا لا

ألف باء الترية

أستطيع أن.. فما بالك عندما أكون لوحدي في السرير، ويوجد شيء من الاضطراب، من الخوف، من الظلام، من الطبيعي أن يحصل هذا أيضًا، وأنا أصلًا معتاد أنه ليس لدي إشكال بالشعور بالبلل في البنطلون، أو بالشعور ببقايا الفضلات في اللباس الداخلي أو في كذا.

لا يوجد لديه إشكال، غالب الظن أن هؤلاء يكونوا استمرارًا لجماعة اليقظة، وبالتالي وقاية هؤلاء أن يعالج مسألة اليقظة أن يعرف كيف يقف؟ كيف يُنبّه؟ كيف يتذكر؟ أنه إذا ما توجه مباشرة لقضاء الحاجة أنه سيُحرم من كذا وكذا؛ غالب الظن عندها هذا سيستطيع أن يتنبه إلى ما هو فيه ويُنبه الوالدين ويُعبر عن نفسه.

تبقى مسألة واحدة فقط -وما عداها كما قلت سأرجئه إلى الكلام عنه في الإبانة والتعبير- وهي: أن الطفل يكون عنده إشكالًا حقيقيًا في عدم التحكم، إشكالًا عضويًا. لاحظوا إلى الآن ما دخلنا في النوم، هو صاحي أو هي صاحية.. يكون عنده إشكالًا حقيقيًا؛ بمعنى هو لا يشعر أن هنالك شيء خرج من الجسم، ولما بدأ يشعر كان الأمر انتهى، فات الأوان.. وهذه عادةً مسألتها عند المسالك البولية. بالذات عند الإناث الالتهابات وعند الذكور مسائل أخرى.

ما عدا ذلك ما قلناه يشمل معظم الحالات التي عندها تبول لا إرادي؛ في اليقظة أو التبول الاستثنائي عن التبول الليلي وهو عند السرير. المسألة العضوية هذه سهل جدًا أن يتعرف عليها بعض أطباء الأطفال أو طبيب المسالك البولية.

❖ التبول الليلي:

نأتي الآن إلى التبول الليلي. التبول الليلي الأصل فيه أنه استمرار لحالة اللامبالاة التي عُوِّد عليها. بمعنى المفروض أن سنة ونص سنتين قد تدرب إذا ما كان واعيًا تمامًا لقضية أنه يتنبه ويُنبه عادة ستستمر معه، هو -عذرا بالعبرة- الكبير أحيانًا قد يستغرق بالنوم إلى درجة أنه هو نفسه بالكاد يلحق نفسه لو حصل عنده حاجة، ولكن الأصل في معظم الحالات أنه تدريب ما قبل ذلك سنًا سيعوّده على أنه عندما يشعر بهذا في النوم يستطيع أن يتنبه له وأن يقوم.

الإشكال أن الأهل يتعاملون مع النوم على أنه حالة واحدة، والنوم مراتب. للنوم أربعة مراحل.

1- الطفل في المرحلة الأولى والثانية تقريبًا هو ما زال في حالة شبه يقظة. الأهل عليهم أن يعرفوا متى يحصل التبول، إذا حصل في هذه المرحلة فمعظم ما قلناه في اليقظة يحقّ هنا.

2- مرة ثانية: المرحلة الأولى والتي تكون أول أربعين دقيقة تقريبًا، إذا جاءت الأم حتى تطمئن على الابن أو الابنة -ناموا وتغطوا- وكان يوجد بلل؛ إذن معناها أنه يحصل التبول في المرحلة الأولى، المرحلة الأولى تقترب كثيرًا من مرحلة اليقظة، التعامل معها عمومًا سيكون مع عموم ما تعاملنا معه قبل ذلك؛ هل هو خائف؟ هل هو ما يعرف أن يعبر؟ هل هو معتاد على الأمر؟ لا يشعر بأنه هنالك أي نتيجة إذا استمر؟ لا..

أنت الأصل أن المنبهات شغالة عندك وأنت شبه مستيقظ نوعًا ما. فغالب ما قلناه قبل قليل يحق في المرحلة الأولى.

2- لكن مرحلة -دعونا نسميها- نصف المرحلة الثانية والثالثة، هنا دخل في النوم العميق، وهي مرحلة الأحلام dream stage. في النوم العميق التعامل معه يختلف، لماذا هذا الكلام مهم؟ إذا أنا دخلت إذا ابني نام أو ابنتي نامت، أنا رأيتهما نائمة أصدرت صوت حولها وكذا وهي نائمة، لما يكون البلبل حصل بعد ساعة ونص فما بعدها؛ إذا أنت تتكلمين عن تبول لا إرادي في مرحلة النوم العميق. وبالتالي ما الذي يفيدني؟ يُظلم الطفل إذا عاملناه معاملة المرحلة الأولى واليقظة؛ "أنت تستهبل! كم مرة حكيت لك!..." ويبدأ ينهال الأهل عليه بسيل من الوعظ وتحميله ما لا يطيق... لا، هو نائم نومًا عميقًا الآن، هذا يحتاج إلى تدريب من نوع خاص، ولا يُعامل معاملة اليقظة، ولا معاملة المرحلة الأولى من النوم. طبعًا بالمناسبة طالما قلت هذا، المرحلة الأولى من النوم تقريبًا مثل المرحلة الأخيرة؛ بمعنى إذا قلنا الطفل مثلاً دخل إلى سرير -هذه الأيام طبعًا هذا خيال علمي-، إذا اعتبرنا أنه نام الساعة تسعة، من تسعة إلى عشرة أنا عبد الرحمن أعامل (من تسعة إلى عشرة) مساءً مثل (من ستة إلى سبعة صباحًا). مثلاً دخل بالنوم الساعة تسعة مساءً.. ثم استغرق... أعامل (من تسعة إلى عشرة) مثل معاملة (من خمسة ونص إلى سبعة) أو (ستة إلى سبعة) صباحًا = بداية النوم وآخر النوم = هاتان المرحلتان يكون أول ما دخل مازال يوجد قدر من التنبيه الذي ممكن يحصل عنده ويتنبه له، وآخرها اقتراب من الاستيقاظ، ما بينهما النوم العميق هذا أنا لا أعامله معاملة الطرفين؛ وهنا يظلم الأهالي كثيرًا من الأبناء، لما يبدوون بسيل من التهم "وأنت ما تساعدني وأنت أكيد..." هذا مهم حتى لا يظلم الأهالي أنفسهم طبعًا ثم أطفالهم.

❖ كيفية التعامل مع هذه الحالة:

- التبول الليلي أو ما يسمى التبول اللاإرادي هو مرحلة متقدمة عند الإنسان عمومًا، معنى مرحلة متقدمة أن التعامل معها يحتاج إلى قدر من النضج، حتى عند الكبار؛ بمعنى حتى الكبار إذا سألتهم في من حولكم.. إذا سألتهم بعض الناس الذين عانوا في شيء في يوم من الأيام؛ سيقولون لكم: "نعم أحيانًا 11 سنة و12 و15 وفي سن الجامعة"، نعم هنالك استشعار بخوف ولذلك دائمًا يكون مثلاً ضوء الحمام مضاء "لهذه الدرجة؟!" نعم، لأن هذا يحتاج إلى تدريب. بعض الناس نومهم العميق يُلجئهم إلى -عذرًا- تغيير ملابسهم الداخلية؛ لأنه لما يكون صاحي أنه صار معه شيء يكون في أواخر ال... يعني يكاد أن يلحق نفسه، هذا موجود حتى في عالم الكبار!

ما عندي شيء أستطيع أن أستند عليه في تفصيل أسبابها في عالم الكبار: لاحظوا ما عندهم تبول ليلي، لكن الذي عنده هو عدم الاستشعار المبكر للحاجة؛ فالذي يحصل أنه لما يستيقظ بالكاد يلحق نفسه، هذا موجود وبالمناسبة موجود عند الإناث أكثر من الذكور. ما السبب الحقيقي لذلك؟ ما عندي

علم، لما أقول ما عندي علم أعني ما عندي مستند علمي أستطيع أن أبني عليه مائة في المائة أو حتى ثمانين في المائة.

لِمَ أقول هذا الكلام؟ من باب أولى إذن ابن الثالثة والرابعة يحتاج منا إلى تدريب وإلى صححة؛ لأنه مسألة أن يستغرق في النوم ثم يأتيه منبه داخلي هذا يحتاج إلى تدريب مضاعف.

- لماذا الطفل في هذا السن يحتاج إلى وعي أكثر؟

أولاً: هو ما زال مستغرقًا مع حالة السنتين ثلاثة الأولى؛ وبالتالي هو مستغرق مع أنه معتاد على أنه المثانة عنده تُمَلَأ بنمط معين، وهو يخرجها بنمط معين أو بتزامن معين أو بتقسيم... مازال ما بدأ يعتاد أنه هل ممكن أنا أدخل إلى النوم بدون الاحتياج أن أقوم مرتين ثلاثة مثل ما كنت، هو مازال هذا الأمر ليس معتادًا عليه. أنتم تعرفون الرُّضْع.. حليب وسوائل بكثرة... الكلى شغالة.. مثانة صغيرة.. هذا شيئًا فشيئًا النمو الذي يحصل معه مع اختلاف الطعام هو ما زال لا يدركه.

- ما العمل إذا؟

هنا دائما أقول للأهالي مسألة بسيطة جدًا، أولادكم سنة ونص سنتين، ابدؤوا اشرحوا لهم -وهذا يكون مدخلًا جيدًا على قضية حتى التعلم على الحياة وكذا- جسم الإنسان؛ بمعنى نريه.. نحكي له: "تعال نريك" والآن متاح اليوتيوبات والانترنت والرسومات وغيرها.. الطفل رضيع نحكي له: كيف أن انظر المكان الذي يطلع منه السائل الآن.. هذا هو.. ترى المثانة كم صغيرة لكن الآن أنت تكبر، والآن أنت تأكل أشياء ثانية، فالشيء ليس كله يذهب عن طريق المثانة، لا.. يروح كله عن طريق المعدة، ويتحول إلى شيء آخر، وبالتالي الآن صار احتياجك للحمام يختلف.

أتوقف هنا: هذا الكلام هل يعني الطفل؟ نعم.

لِمَ؟ لما يرى الأمر أو يفهمه أو على الأقل يُقال له؛ استعداده النفسي الآن لقضية الذهاب إلى الخلاء اختلفت، من قبل هو يتأثر تأثرًا سلبيًا Passive influence، بمعنى أنه هو ليس فاعلاً، هو حصل عنده شيء ومباشرة استجاب، هو الآن يقال له: "بالمناسبة أنت ما عدت ذلك الشخص، أنت احتياجك للخلاء اختلف.. طعامك اختلف.. جسمك الداخلي اختلف.."

هذه المعلومة إذا كررت عليه مرة مرتين؛ لما يمر عليه نفس المنبه سيختلف تعامله معها، صار عنده استعداد نفسي.. استعداد علمي مختلف. وبالتالي لا تستقلوا بقضية أن يُشرح له هذا الأمر.. بكل بساطة.. طبعًا كما قلت لكم هذا الشرح يُعين لاحقًا لما سنتكلم على قضية الحياء والخجل؛ يُعينه حتى في قضية أنه أعضاء الجسم وتغطيتها... لكن الذي يعني هنا أنه يُدرّس الطفل أنه زمان أنت كنت تحتاج، وسيكون متعب بالنسبة لك أنك كل نص ساعة تقول لي لأنه جسمك كان يختلف، الحليب الذي كنت تأخذه،

ألف باء التربية

حركتك مختلفة، أنت الآن طعامك مختلف، جسمك مختلف، تنهك مختلف، حركتك مختلفة... هذا كله يجعل ما عندك حجة أنك يجري منك ما يجري من الأطفال الصغار.

ما عدا ذلك يُعوّد الطفل قبل النوم بساعة مثلاً- نحكي عن ثلاث سنوات مثلاً أو سنتين وهذا غير قضية اليقظة- يُعوّد أنه يروح على الحمام حتى لو ما كان محتاجاً. وهنا أحكي لكم إلى أي درجة في عندنا إشكال في التربية، وبالتالي ما عندي أي عَجَب لما يكون في عندي حالات تبول ليلي عند خمس وستة وسبعة سنوات، في النوادي وفي التعليم الحر يُشرح لهم القانون أنه: (أنت عندك مجلس التعليمي-تذكرون لما قلنا كيف يدار المجلس-، قبلها في عندك استراحة: أكل، شرب... لأنه ممنوع أنك تدخل معك زجاجة الماء، وممنوع أنك تذهب إلى الخلاء) مع كل هذا ومع أنه يكون عندهم أحياناً نصف ساعة استراحة، لما يبدأ الدرس بعد قليل "دكتور أريد أن أذهب..."، أنا معتاد أحكي لهم هذه العبارة: "مضطر؟" أقول له: "مضطر إلى درجة إنك لو ما طلعت الآن ممكن نخسر الموكيت الذي تجلس عليه! أو ممكن صاحبك بعد قليل يحكي طلعت ريحة" طبعاً أنا أحولها إلى نكتة، يقول "لا، ليس لهذه الدرجة"، أحكي له: "إذن ممكن تصبر..". الإشكال أن تتكرر من ابن التاسعة والعاشر والحادية عشر، بالكاد المجلس بدأ من ربع ساعة.. "دكتور".. بعدها يصير يتحرك = هو لا يسمح لي بالذهاب للخلاء لكن أنا مضطر عن جد... هو لا يُمثل، وأنا أنظر وأتجاوز، بعد قليل يصير يتحرك.. وأنا أتجاوز.. طبعاً لماذا أتجاوز؟ الألم.. أنت ينبغي أن تتعرض لهذا حتى مرة الثانية لما تكون تلعب babyfoot أو تنس مع زملائك تتذكر أنه قبل ما يحين وقت المجلس تذهب إلى الخلاء. لاحظوا أنا أحكي على 11 سنة! قل هذا الكلام على ابن الثالثة! الأهل لم يُعوّدوا ابن الحادية عشر أن يُمسك نفسه ويقول: لا لهذه اللذة اللحظية لأنه في عندي حاجة ينبغي أن أقضيها. ما تُعوّد على ذلك! فما بالكم طبعاً في مسائل أسوأ من ذلك: يذهب ويرجع في دقيقة! أنا طبعاً أكون مشغولاً ب "هل غسل؟! تأكد من تنزهه من البول؟!" هذا تعلم أن ملابسه الداخلية تكون نظيفة أم ليست نظيفة.. كيف يُصلي معنا!

توجد مسائل كثيرة.. هذا كله في الخطة اليومية المفترض أنه مررنا عليه.. لكن تُشعركم بأنه أي حديث عن تبول ليلي عند ابن الرابعة والخامسة وهو لا يعرف أن يتنبه لضرورة الذهاب إلى الخلاء وهو في الاستراحة! إذن من الأشياء التي يُعوّد عليها الطفل قبل النوم التوجه وهذا قلناه في الخطة، لكنه تحديداً لجماعة التبول الليلي الذين نخشى عليهم ذلك أو جرى منهم ذلك أن يُعوّد أنك لازم تذهب على الخلاء.

. القضية الثانية: - ذكرناها في الخطة- الناس الذي فجأة يتذكر على السرير يريد أن يأكل ويشرب على السرير، ويريد عصير على السرير، هذا قولاً واحداً تبع التبول الليلي نقول: لا، يعني هو نحن الطبيعي قلنا: لا للذي هو يمر بحالة اعتيادية فما بالك بمن عنده تبول ليلي، يتوجه إلى الخلاء، ولا يأكل شيء ولا يشرب أي شيء بعده، أيضاً من المسائل المهمة لارتباط بعض نظريات جماعة التبول الليلي بقضية الخوف أن نتأكد أنه ليس لديه خوف، بعض الناس يقولون أنه ممكن يكون عنده خوف، نعم هذه

ألف باء الترية

موجودة، نتأكد أنه مُعبر عن نفسه، ليس لديه مسألة تضايقه، لم يتجه إلى النوم وهو مثلاً قد ضربه أبوه أو أخذ بهدلة من والدته، هذا اذا تأكدنا منه إذاً يعني غالباً الأمور طيبة ان شاء الله، لكن الذي يعني هنا مرة أخرى كثير من تدريبات اليقظة تريحكم من كل ما نقوله هنا.

بعد ذلك نعود الطفل على أنه أنا سأكون معك وفي المرحلة الاولى أنا سأنيك، يعني أنا سآتي مرتين خلال النوم أيقظك حتى تذهب تقضي حاجتك، الاهالي يقولوا لك: أنا أقوم بها لكن لا يزال عندي مشكلة!، ما الذي تفعله أنت؟ طريقة التنبيه وطريقة اليقظة كأنه لا يزال نائم، يؤخذ محمول يقضي حاجته بعدها يرجع للسير، أنا نائم!، ويمكن لو سألتيه صباحاً يقول لك: كأني كنت أحلم بحلم أنك أتيت حملتي من السرير، إذا ما الذي يجب أن أفعله؟ يصحى، ستقولون: يا دكتور إذا صبحي سنتغلب بنومه!!، هذه الغلبة أنا أريدها حتى يعرف ان الحاجة هذه (مؤلة) إما ما يفعل ما يضطره اليه من اكل وشرب، أو يعرف أنه تدريجياً سنبداً نتخلص منها بإرادتنا، أما أنك تيقظيه وتأخذه وتحمله أو والده أو الشغالة -إذا شغالة في البيت- لا هذا لا يحل، الحل: أن يوقظ وتدعيه يفتح عينه ويتأكد أنك من؟ أنا ماما، ماذا نفعل؟ لنذهب للحمام، لماذا؟ حتى لا أبلل السرير أو غيره، يذهب يقضي حاجته ويعود، وبعد ساعتين ثلاثة نفعل نفس الفعل، مرة بعدها مرة واحدة، بعدها انتهى، لكن كثير = من الاهالي الذين رأيت عندهم إشكال: والله أنا أوقظه دكتور ثلاث أربع مرات، لم توقظه، أقول: لا، انت تأخذه من السرير إلى قضاء الحاجة لم توقظه، هو لم يستيقظ، هو يمارس الامر ما زال يمارسه لا إرادياً! أنت الذي تمارسه ليس هو.

جماعة الانسحاب هم من عندهم مشكلة هنا، يعني هي لا تنسحب في اليقظة ولا بالنوم!، والاكثر إشكالاً من ذلك التي هي منسحبة وتركت الأمر على العاملة، طبعاً ناهيكم عن قضية أنه يكون طفل في الخامسة والسادسة ذكر والعاملة تكشف عليه وعلى وعورته!، هذا كله ليس لدينا إشكال فيه المهم الأم تكون نائمة حرام لأنها امرأة عاطلة خلال النهار.

المرحلة التي بعد ذلك لاحظوا نحن تعدينا بأن قلنا له و شرحنا، خففنا من الاكل والشرب قبل النوم، عودناه أن يذهب يقضي حاجاته، تأكدنا أنه لا يوجد أي اضطراب ممكن يجعله يخاف أو يتوتر وهو مقبل على النوم، تأكدنا أنه الامر في النوم العميق بعد ذلك كله دربناه قلنا: سنأتي نوقظه، ويستيقظ ويتحقق عنده أنه مستيقظ، بعد ذلك نضع منبه كمنبه الاستيقاظ يستيقظ عليه هو يستشعر أنه هو قام بإرادته، ستقولون: يوقظنا أيضاً!، لا مشكلة يعني اذا وصل الأمر لدرجة أنه عندكم حالة تستوجب ذلك وصل خمسة ستة وأصبحتم تخشوا أن يذهب إلى المدرسة ويخجل أمام زملائه، او تخجل أمام زميلاتها لا، ليس لدي إشكال يستيقظ ويوقظك تأخذه إلى الحمام، ما عندي مشكلة هذا ونس الليل هذا يريد يستشعره، لكن لاحقاً قل له: لا هذا الأمر عليك أنت من تقوم فيه؛ أظن الى هنا غالباً ليس لدينا مشاكل عضوية أو مشاكل نفسية الأمر ممكن تجاوزه.

يبقى مسألة -تكلمت عليها مرور سريع أيام الخطة وقلت سنفصل فيها هنا- هي مشكلة اللهايات ومص الإصبع، مرينا عليها بالخطة إذا تتذكرون وقلنا أنّ البعض أحيانا إما الابن أو الابنة يكونوا استغفلوهم واعتادوا على الأمر، أو هم عودوهم على قضية اللهاية أيا كان، جماعة الاسنان تحديدًا أكثر من غيرهم ومعهم يتقاطعون أحيانا مع الجماعة النفسيين: أنه معك إلى الثالثة مقبول بعد ذلك يخشى أولاً: اعتياد نفسي، ويخشى على قضية الفك والاسنان وغيرهم. ثلاث سنوات ليس ثلاث شهور، طبعاً لما نقول: يا جماعة يسمح لا يعني أنه هذا هو الأصح لكن هذا أنت معك إلى سن الثالثة لا إشكال مع أن جماعة الاسنان -أظن الآن لا أعرف يجب أراجع هذا قليلاً أجدد معلوماتي هل جماعة الأسنان ما زالوا حول الثالثة؟ لأنه كلما تظهر اضطرابات أكثر يمكن يكبروا الموضوع-، طبعاً إذا رجعتم إلى الخطة نحن نقول الأفضل في قضية مص الاصبع أن يتعلم الطفل أن ينام وحده.

هناك نسب مئوية في مص الإصبع بنسبة أربعين بالمئة قد يستمر إلى الخمس سنوات عند الاطفال، طبعاً هذه الدراسات عادة تأتينا من الغرب وأظن أنه مع تداخل الثقافات والعالم الرقمي ممكن تكون نفس الأرقام، أربعين بالمئة إلى خمس سنوات، عشرين بالمئة إلى عشر سنوات، خمسة بالمئة إلى خمسة عشر سنة، واحد بالمئة بعدها، وأظن ذكرت لكم أنه كانت تأتيني حالات لطالبات جامعات ما زالوا إلى الآن ومتزوجات ما زلن يمارسن مص الإصبع عن النوم، لدرجة أذكر الحالة التي جاءتني كانت أغرب حالة بالنسبة لي! فتاة في سكن جامعي مشكلتها طبعاً هي ظاهر المشكلة عندها التي جاءت به قضية مص الإصبع لكن الإشكال الحقيقي كان عندها اكتئاب لكنه ما استوقفي أنها في السكن الجامعي المشكلة الوحيدة عندها أنه تضطرب أن يراها أحد وهي نائمة وهي تمص اصبعها، ذكرنا هذا موجود كنسبة عند الاناث أكثر من الذكور وعند الأطفال الذين امهاتهم يعملن خارج البيت كنسب مئوية، الأسباب يقولوا ممكن يكون بسبب الخوف، والقلق، والتقليد أنه يقلد غيره، الفراغ والملل، يكون جالس على السرير ليس لديه ما ينفعه وغير نعسان ولا يقرأ ولا غيره فيمص إصبعه.

من أكثر الآثار الناتجة عنها السلبية آثار جسدية وآثار روحية، الآثار الجسدية: قضية الفك، الآثار الروحية سوء التواصل، الأطفال الذين لديهم مص الإصبع يتأثر هذا يؤثر بشكل واضح على شخصيتهم، الشخصية أضعف، مترددة، تأتأة لاحقاً -سنتكلم عليها-، قضية الشعور بأنه أنا أصغر ممن حولي ما يسمى لاحقاً بـ "الرهاب الاجتماعي". كل هذا كآثار نفسية مرتبطة عند كثير من الحالات في حالة وجود مص الإصبع إلى سن متقدمة نوعاً ما.

العلاج عادة يكون علاج الأسباب، جائع يأكل، خائف نطمئنه لا يدخل إلى السرير وهو لديه هذا الشيء، حوله ناس يمارسوها نحاول نبعده عن الناس الذين يقلدهم، من العلاجات هنا التجاهل، خصوصاً إذا كان التجاهل عند ابني أو ابنتي أنا أعلم أنه ممكن يمر، بعض الأهالي يسلطوا ضوء على

المسألة ويزيدوا المشكلة حصلت مرتين ثلاثة لا مشكلة، لكن مستمرة والتجاهل لا يعمل لا، إذا التجاهل لم ينفعه.

البعض يرى أنه اللهاية علاج لمن يمص الاصبع، من يمص الاصبع هناك مشكلة -سبحان الله- أولاً: فيه ملوحة فهو يعتاد على الطعم، لما ينتهي الطعام يعتاد على الملمس، ولذلك شركات اللهايات في العالم تحاول محاكاة هذا الشكل، الإشكال أن البعض قد يصل إلى مرحلة أنه ما يعود الاصبع هذا ينفع، الاصبع هذا مصه ذهب الملح الذي فيه اصبعه الثاني، الآن هذا ذهب الملح منه الآخر جف ففيه ملوحة فيعود عليه مرة أخرى، ففي بعض الحالات يقول لك الطفل يمسك أكثر من الاصبع، الإشكال الأكثر من ذلك أن يمسك أكثر من اصبع في آن واحد تجده واضع الاصبعين مع بعض، فاللهاية يعتبروها حل لأمرين فيتجاوز قضية الملوحة، والقضية الثانية أن الملمس نفسه لا يبقى معتادا عليه وبالتالي لما تزال اللهاية لاحقا ويضع إصبعه لا يعطي نفس الملمس أو الإحساس، الإشكال في اللهاية أنها قد تتحول هي إلى إدمان كان يمسك إصبعه بعدها صارت اللهاية هي التي لا نعرف نعالجها له، ولذلك بالحالتين سيأتي تلك اللحظة التي لا بُد أن نسحب فيها سواء كان مص إصبع أو اللهاية.

من المسائل الجيدة قضية إشغال اليد: كتاب، ورقة، قلم... يمسك له شيء، يمسك عجين يلعب فيه قبل النوم المهم تنشغل اليد. البعض يقول: هل ممكن نتجاوز شيء قلناه من قبل قضية أنه مفروض لا يأكل أو يشرب أن نمسكه مثلاً خياراً أو جزرة عندي مشكلة مص الاصبع أخطر من قضية أنه لا أريده أن يأكل على السرير، يأكل المهم لا يبقى يمص إصبعه، النبي آدم -سبحان الله- عنده القدرة على التكيف والتحليل، يعني ممكن يخلص جزرتين وخياراً ويمص إصبعه بعدها عادي جداً ويطلب أركيلة أيضاً لا يوجد مشاكل، أنا قصدي أنه قد تحصل، كل شيء أقوله أكيد ممكن يكون له استثناء، لما نأتي على الأعمار الأكبر قليلاً، لما نصل إلى خمسة وستة المفروض هنا الوعظ يلعب دور كبير، أن يقال له: ما تمارسه أنت هذا ممارسة أطفال صغار أنت أكبر من ذلك وهذا سيؤثر عليك، ومن الأشياء أنه مع الوعظ يتفق معه على إجراء معين، تذكرنا أن يقوم بها أمام المرأة نقول له: تعال قف ومص إصبعك قدام المرأة، لن يقبل وستلاحظون ذلك لأن هو المنظر أصلاً لست أريده أن يرى نفسه، فلما يفعل ذلك وهو يرى حاله يستحضر الصورة حينها لما يمص إصبعه سيتذكر، فأنا عملت مزاحمة مدخلات بطريقة مدافعة أشياء لا أريدها؛ من الأشياء أن يتفق معه على حركة معينة خصوصاً إذا كان في وجود المجتمع أني لا أريد أن أنبهك لكن اتفق معك على حركة إذا عملتها أنت تتنبه أنك تمص إصبعك لأنه يصل الأمر إلى درجة أنه ممكن يكون يمارسها أمام الناس! يعني فجأة توتر، أصحابه أخذوا كرة وضع إصبعه في فمه.

هنا مسألة ابنه عليها دائماً اتفقوا على حركة غير معتادة، حكيت لكم قصة أحد الأخوة مرة قال: أنه كان متفق أنه يحك أنفه.. لكن حكة الأنف هذه ممكن تحصل كثير، فهو الابن يشعر أني لم أفعل شيء لما يحك أنفه آخر، شيء غضب: أنا لم أفعل شيء!! الأب غير مدرك أنه هو بجلسة اجتماعية فكل مدة يحك

ألف باء الترية

أنفه فالابن حكة الأنف معناها إنه أنا فعلت شيء، فإذا تتفق معه على حركة غير معتادة، لا تعرفون ما حركة غير معتادة تنتف شعرها مثلاً تلطم مثلاً أي شيء، آخر حل هو زيارة طبيب الأسنان، طبيب الأسنان يدخل هنا تربوياً لأنه يصل الأمر إلى أنه ممكن أن يضع له جهاز مؤذي غير مؤلم ينزعج منه الطفل لما يضع اصبعه يصبح عنده احساس سيء جداً الطريقة ناجحة أنا أعرف حالات بلغ الحال بالبنت أظن إلى سن السابعة وهي تمص الإصبعين، جربوا كل الحلول وهذا الجهاز حل الموضوع.

الأسبوع القادم سيكون لدينا مجلس مهم جداً، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.